

Rdzeń wszystkich objawów — *nadwartościowanie*

Samoocena nieproporcjonalnie oparta na kontroli kształtu/wagi. To jedyny centralny mechanizm CBT-E — wszystko inne (restrykcja, fear foods, checking) z niego wynika.

CZAS: 30–40 min psychoedukacji + diagnostyka

REALIZACJA: faza 2 CBT-E (sesje 8–16), po stabilizacji jedzenia

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, rozdz. 8 — *over-evaluation of shape and weight*); Fairburn, Cooper & Shafran (2003, model transdiagnostyczny)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **cztery objawy** nadwartościowania (zaprzątnięcie myśli, checking/avoidance, „czucie się grubym/-ą”, marginalizacja innych domen). Sekcja 02 — **sześć kroków pracy**: identyfikacja → pie chart → rozszerzanie samooceny. Sekcja 03 — **arkusz** do wypełnienia.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Nadwartościowanie (ang. *over-evaluation of shape and weight*) to **centralny mechanizm** AN w modelu transdiagnostycznym Fairburna (2008). Definicja: samoocena *nieproporcjonalnie* oparta na kontroli kształtu, wagi i jedzenia — w przeciwieństwie do zdrowej samooceny opartej na wielu domenach (relacje, praca, zainteresowania, wartości). Z nadwartościowania wynikają **wszystkie** objawy AN: restrykcja, fear foods, food rules, checking, avoidance. **Konsekwencja**: bez pracy nad nadwartościowaniem zmiany behawioralne się nie utrwalają — pacjent znajdzie nowe sposoby kontroli. Cel CBT-E: **rozszerzenie** samooceny (nie eliminacja troski o ciało — to zdrowe), żeby kontrola wagi przestała być dominującą domeną.

01 Cztery objawy nadwartościowania — jak rozpoznać

OBJAW

JAK SIĘ MANIFESTUJE W CODZIENNOŚCI PACJENTA

1 · Zaprzątnięcie myśli kształtem i wagą	Myśli o wadze, ciele, jedzeniu zajmują znaczną część dnia (typowo >50% czasu czuwania). Pacjent ma wrażenie, że „ <i>nie da się o tym nie myśleć</i> ” — to skutek głodzenia + nadwartościowania.
2 · Checking + avoidance	Body checking (lustro, pomiary, dotyk, porównania) <i>lub</i> body avoidance (luźne ubrania, brak luster, fotografii). Często naprzemiennie. Oba podtrzymują nadwartościowanie.
3 · „Czucie się grubym/-ą”	Subiektywne odczucie „ <i>jestem gruby/-a</i> ” niezależne od obiektywnej masy. Często wywołane innymi emocjami (lęk, smutek, wstyd) — pacjent przekłada je na ciało. <i>Feeling fat</i> jest emocją, nie faktem.
4 · Marginalizacja innych domen	Relacje, praca, hobby, wartości, pasje — wszystko traci znaczenie wobec kontroli wagi. Pacjent rezygnuje z aktywności społecznych, kreatywnych, zawodowych „ <i>żeby się skupić</i> ”. To skutek, nie wybór.

Cel CBT-E to rozszerzenie samooceny, nie eliminacja troski o ciało. Zdrowa osoba też ma troskę o wygląd — różnica jest w proporcji. Cel: kontrola wagi staje się jedną z wielu domen, nie dominującą.

1. **Psychoedukacja** — „Twoja samoocena nieproporcjonalnie opiera się na kontroli wagi i jedzenia. To rdzeń AN. Inne osoby mają samoocenę opartą na wielu rzeczach — to jest celem terapii dla Ciebie też”. Bez tego rozumienia — pacjent nie widzi sensu pracy.
2. **Identyfikacja własnej samooceny — pie chart** — pacjent rysuje koło i dzieli je na „kawałki” według wagi domen w jego samoocenie. Typowo: 70–90% to kontrola wagi/jedzenia, 10–30% reszta. Wizualizacja problemu (zob. karta pie-chart).
3. **Rozszerzanie samooceny — domeny do wzmocnienia** — „Co jeszcze mogłoby być częścią Twojej samooceny?” Relacje, praca, hobby, kreatywność, wartości, drobne osiągnięcia. Nie „zastąpienie” — dodanie. Cel: za rok 30–40% w jednej domenie, reszta rozłożona.
4. **Konkretne zadania w nowych domenach** — pacjent *codziennie* wykonuje aktywności w wybranych domenach (np. rozmowa z bliskim, projekt twórczy, czytanie, sport rekreacyjny — bez kompulsywności). Bez tego rozszerzanie zostaje teoretyczne.
5. **Redukcja checking/avoidance** — bez tego nadwartościowanie się utrzymuje (mechanizm samoutrwalający). Konkretne protokoły — zob. karty body-checking i body-avoid.
6. **Praca z „feeling fat”** — kiedy pacjent mówi „czuję się gruby/-a”, pytaj: „Co jeszcze czujesz? Co się działo przed tym uczuciem?” Często ujawnia się inna emocja (lęk, smutek, wstyd, gniew) przekładana na ciało.

ILE CZASU DZIENNIE ZAJMUJĄ MYŚLI O WADZE, CIELE, JEDZENIU

— szacunek: 10% / 30% / 50% / 70% / 90%; daje miarę zaprzętnięcia myśli

CO POZA KONTROLĄ WAGI OBECNIE BUDUJE MOJĄ SAMOOCENĘ

— bądź szczerzy/-a; jeśli „nic” lub „mało” — to jest właśnie cel pracy

TRZY DOMENY, KTÓRE CHCIAŁBYM/-ŁABYM ROZWINĄĆ JAKO CZĘŚĆ SAMOOCENY

— relacje, praca, hobby, kreatywność, wartości, sport rekreacyjny, działalność społeczna

CO KONKRETNIE ZROBIĘ W TYM TYGODNIU W JEDNEJ Z TYCH DOMEN

— konkretne, mierzalne, niewielkie; nie „będę więcej spotykać się z ludźmi”, lecz „w czwartek zadzwonię do X”

Klucz: nadwartościowanie jest *jedynym* centralnym mechanizmem AN w modelu Fairburna — wszystkie inne objawy (restrykcja, fear foods, checking, avoidance, „feeling fat”) z niego wynikają. Bez pracy nad nadwartościowaniem zmiany behawioralne *nie* się utrwalają — pacjent znajdzie nowe sposoby kontroli (efekt odbicia — ang. *rebound*). Praca jest *długa* — rozszerzanie samooceny trwa miesiące, nie sesje. Komunikat: „nie chodzi o to, żebyś przestał/-ła dbać o ciało. Chodzi o to, żeby ciało stało się jedną z wielu rzeczy, na których budujesz swoje „kim jestem” — nie jedyną”.

△ Praca nad nadwartościowaniem wymaga wcześniejszej stabilizacji medycznej i regularnego jedzenia (fundament wczesnej fazy CBT-E). U pacjenta w stanie głodzenia poznawcze rozszerzanie samooceny pracuje z ograniczoną plastycznością mózgu (Minnesota Study). Najpierw 3+2+1 + rehabilitacja, później nadwartościowanie.